

ΟΞΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Γενικά: Το άσθμα αποτελεί μια ετερογενή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσος των αεραγωγών, στην οποία πολλά φλεγμονώδη κύτταρα και κυτταρικά συστατικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σταδιακά σε αύξηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας με υποτροπιάζοντα επεισόδια. Τα επεισόδια εμφανίζονται συνήθως τη νύχτα ή νωρίς το πρωί και χαρακτηρίζονται από διάχυτη, μεταβλητή απόφραξη των αεραγωγών, που είναι συχνά πλήρως αναστρέψιμη. Τα συμπτώματα της νόσου ποικίλουν σε ό,τι αφορά στο είδος, την ένταση και τη συχνότητα της εμφάνισής τους. Ο ασθενής παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα επεισόδια **έντονου βήχα, αναπνευστικού συριγμού και δύσπνοιας**. Η διάγνωση της νόσου εδραιώνεται με σπироμέτρηση (*δοκιμασία αναστρεψιμότητας*), όταν η μεταβολή του FEV₁ μετά από βρογχοδιαστολή με Σαλβουταμόλη είναι μεγαλύτερη του 12% και των 200 ml.

Συνήθεις παράγοντες οι οποίοι ενεργοποιούν τις παροξύνσεις άσθματος σε ενήλικες και παιδιά είναι οι ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, η άσκηση, το κάπνισμα, τα αλλεργιογόνα.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο ή στο ΤΕΠ κυανωτικός, με έντονη δύσπνοια ή/και ορθόπνοια, παράταση της εκπνοής, έντονο συριγμό ή «σιωπηλό θώρακα» ως δείγμα σοβαρής απόφραξης. Ομιλεί αδύναμα και κοφτά. Πιθανώς να παραπονιέται για συσφιγτικό άλγος θώρακα και να εμφανίζει χρήση των επικουρικών αναπνευστικών μυών. Η σοβαρή κι αιφνίδια υποξία προκαλεί ταχυκαρδία [σφύξεις (HR) > 120/λεπτό], ταχύπνοια [αναπνευστική συχνότητα (RR) > 25/λεπτό], υπέρταση (ΑΠ > 180/110 mmHg) κι εφίδρωση. Επί εμμένουσας κρίσης ή/και μη απάντησης στην αρχική θεραπεία μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία, υπόταση, παράδοξος σφυγμός, διαταραχή επιπέδου συνείδησης και κώμα.

Ιστορικό: Από το ιστορικό, προ της κρίσεως άσθματος, ο ασθενής πιθανώς να αναφέρει άσκηση, επαφή με ζώα, έκθεση σε ψυχρό/υγρό περιβάλλον, έκθεση σε γύρη, φυτά, καπνό, μούχλα κι άλλα αλλεργιογόνα, λήψη φαρμάκων (*ασπιρίνη, ΜΣΑΦ, β-αναστολείς*), λοίμωξη του αναπνευστικού (*85% των κρίσεων οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις*), έντονο στρες κ.ά.

Στην περίπτωση εμφάνισης οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, υψηλή πιθανότητα για άσθμα εγείρει το ατομικό ιστορικό ατοπίας, το οικογενειακό ιστορικό άσθματος ή ατοπίας, ο διάχυτος συριγμός στην ακρόαση του θώρακα, το ιστορικό μειωμένου FEV₁ ή PEF για τα οποία δεν υπάρχει άλλη προφανής αιτία, ο τρόμος από εξεσημασμένη χρήση β-διεγερτών, καθώς και η ανεξήγητη ηωσινοφιλία στη γενική αίματος ή/και τα υψηλά επίπεδα της IgE.

Διαφορική Διάγνωση: Στους ασθενείς με πιθανό άσθμα η Δ/Δ διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και τα συμπτώματα του ασθενούς. Στη Δ/Δ θα πρέπει να συμπεριληφθούν νοσήματα όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ), η κυστική ίνωση, οι βρογχεκτασίες, το ξένο σώμα στο τραχειοβρογχικό δένδρο, η ΓΟΠΝ, η πάρεση-δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών, η πνευμονική εμβολή, η Σαρκοείδωση, το σύνδρομο καρκινοειδούς, η λήψη φαρμάκων (*π.χ: λήψη αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου*), η κοκκιωμάτωση Wegener, η Λεμφαγγειολειομυομάτωση, κ.ά.

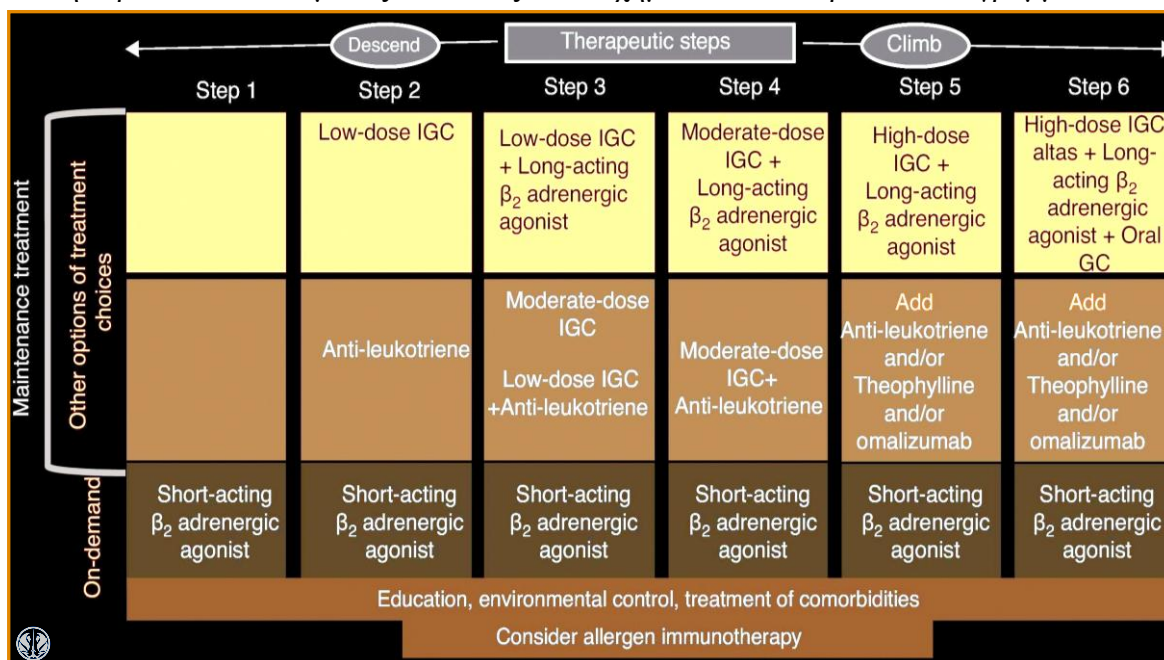
Θεραπευτική παρέμβαση

1. Επιχειρούμε άμεσα **βρογχοδιαστολή**, χορηγώντας 1 amp. **Berovent** (*Aerolin + Atrovent*) και 1 amp. **Budesonide** (*Pulmicort*), με μάσκα νεφελοποίησης, με ροή O₂ στα 5-8 lt/min.
2. Μετρούμε τα ζωτικά σημεία: [*ΑΠ, σφύξεις (HR), αναπνευστική συχνότητα (RR), κορεσμό οξυγόνου (SpO₂)*]. Εκτελούμε ΗΚΓ για τον έλεγχο ρυθμού και αρρυθμιών, ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία ανά 10-15 λεπτά (*ή θέτουμε τον ασθενή σε monitoring ζωτικών σημείων και ΗΚΓ*), ιδίως σε περίπτωση βαριάς ή μη βελτιούμενης ασθματικής κρίσης.
3. Ακροαζόμαστε τακτικά και προσεκτικά τον ασθενή κι εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν επαναλαμβάνουμε ανά 15-20 λεπτά την βρογχοδιαστολή με 1 amp. Aerolin ή Berovent και 1 amp. Pulmicort, με O₂ (νεφελοποίηση) στα 5-8 lt/min. Στα μεσοδιαστήματα των νεφελοποιήσεων χορηγείται οξυγόνο με υψηλές ροές (8-12 lt/min), με μάσκα Ventouri.

4. Παρακολουθούμε τον ασθενή για 15-20 λεπτά, ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία και εφόσον η κατάσταση δεν βελτιώνεται χορηγούνται 250-500 ml NaCl 0,9% για ενυδάτωση, και **Μεθυλπρεδνιζολόνη**: 1 amp. Lyo-Drol (40 mg, 125 mg ή 500 mg) ή για άμεση δράση **Υδροκορτιζόνη**: 1 amp. Lyo-Cortin (100 mg, 250 mg ή 500 mg) βραδέως iv-bolus ή im.
5. Σε ανθεκτική κρίση άσθματος, έντονο βρογχόσπασμο ή στους ασθενείς με επειγμένη αναπνευστική ανακοπή, χορηγείται **MgSO₄** 1-2 gr (½ ή 1 amp.) εντός 250 ml N/S (iv), για 20-30 λεπτά, ανά 45-60 λεπτά ή κατά άλλους σε εφάπαξ δόση. Επίσης, το Μαγνήσιο (3-5 ml MgSO₄) μπορεί να χορηγηθεί κατά την βρογχοδιαστολή μαζί με τον β-διεγέρτη (*Σαλβουταμόλη*) στη συσκευή νεφελοποίησης, αλλά δεν συστήνεται ως βήμα ρουτίνας.
6. Σε ασθενή που δε λαμβάνει ήδη από του στόματος Θεοφυλλίνη, χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση φόρτισης 5 mg/kg (1-2 amp. **Uniphillin** εντός 250 ml N/S) εντός 20-30 λεπτών και στη συνέχεια σε δόση συντήρησης 0,9 mg/kg/h, με συνεχή έγχυση. Σε ασθενείς που έλαβαν Θεοφυλλίνη, κατά το προηγούμενο 24ωρο, η δόση φόρτισης παραλείπεται.
7. Εφόσον ο ασθενής, παρά τη θεραπευτική αγωγή, έχει σημεία βαριάς ασθματικής κρίσης, με εμμένοντα βρογχόσπασμο, πτώση του επιπέδου συνείδησης, υπόταση κι επειγμένη αναπνευστική ανακοπή, τότε εκτελούμε ένεση ½-1 amp. **Αδρεναλίνης**, αργά υποδορίως.
8. Αν η κατάσταση παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται (π.χ. μείωση της *PEFR*, εξάντληση ή αδύναμη αναπνοή, υποξαιμία, κ.ά.) τότε διακομίζουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (*ECG, BP, HR, RR, SpO₂*) και συνοδεία ιατρού, συνεχίζοντας και εντός του ασθενοφόρου την θεραπευτική αγωγή με βρογχοδιαστολή, ως ανωτέρω.

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Ελέγχουμε αν ο ασθενής λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του και αν συμμορφώνεται στις οδηγίες. Εύκολοι τρόποι ελέγχου συμμόρφωσης στη θεραπεία είναι η παρακολούθηση μέσω της συνταγογράφησης και η καταμέτρηση των εισπνοών ανά συσκευή. Τα βήματα στη θεραπεία του άσθματος απεικονίζονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα:



2. Μαζί με τα εισπνεόμενα (*ICS, LABA/SABA*), χορηγείται και από το στόμα φαρμακευτική αγωγή, με κορτικοστεροειδή, για 5-10 ημέρες: tab. Medrol 16 mg, 1x2 ημερησίως.
3. Ασθενείς με αριθμό ασθματικών παροξύνσεων ≥ 2 το τελευταίο έτος, για τη θεραπεία των οποίων απαιτήθηκε η από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών, θεωρούνται ότι πάσχουν από επίμονο άσθμα, ακόμη και επί απουσίας διαταραχών συμβατών με επίμονο άσθμα και ίσως χρήζουν βιολογικών παραγόντων (*Omalizumab, Mepolizumab*).
4. Παροτρύνουμε τον ασθενή για επικοινωνία, την επαύριον κιάλας, με τον πνευμονολόγο που τον παρακολουθεί, για κλινικό επανέλεγχο, σπιρομέτρηση και λήψη οδηγιών.